# EPICRISIS MÉDICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL | : HOSPITAL DE SAN CARLOS | N° EGRESO | : 85816 |
| SERVICIO | : MEL MUJERES HSC | | |
| FECHA | : 2024-06-02 12:09:00 | | |

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | : MARIBEL ANDREA ALARCON PLACENCIA | | | **RUN** | : 18.747.310-1 |
| **F.Nac** | : 25-09-1994 | **Edad** | : 29 AÑOS, 8 MESES | **Género** | : Femenino |
| **Dirección** | : LOS JAZMINES CASA 19 QUIRIHUE | | | **Comuna** | : QUIRIHUE |
| **Previsión** | : FONASA B | **Teléfono** | : 978404278 | | |
| **Fecha Ingreso** | : 2024-05-23 | **Fecha Egreso** | : 2024-06-02 12:09:00 | **Causal** | : MEDICA |
| **Condición** | : VIVO | **Destino** | : DERIVACIÓN OTRO ESTABLECIMIENTO EN RED | **Derivación** | : TRASLADO OTRO HOSPITAL |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J11.8-INFLUENZA CON OTRAS MANIF., VIRUS NO IDENTIFICADO

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda Tipo II corregida
->Neumonia adquirida en la comunidad
--> Neumonia viral por Influenza A
2. Bacteriemia por S. Epidermidis en tratamiento
3. ITU baja recurrente
--> Vejiga neurogenica
4. Diabetes Mellitus Tipo 1
-->Debut CAD (2007)
5. Limitacion intelectual
6. Institucionalizada

<u>DIAGNÓSTICOS CIE10</u>

1. J10.0-INFLUENZA CON NEUMONIA, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUEZA ESTACI (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Am: DMT1, RM moderado, sepsis de foco cutáneo en marzo del 2023 por upp trocantérea y talon izquierdo
Paciente que se mantiene hospitalizada desde marzo 2024 como caso socio sanitario por red familiar deficiente es derivada desde Hospital de Quirihue, con am de neumonía en manejo con clindamicina + ceftriaxona, 6/7, hoy por aumento de clínica respiratoria y mayor requerimiento de oxigeno es presentada para evaluación.
Laboratorios que destaca Proteina C Reactiva : 199,5 , Crea 0.70, ELP 132/4.5/104, Lactato 1.0, glicemia 395, pH : 7,41 pCO2 : 32,6, pO2 : 151,7, HCO3 ACT. : 20,7 *, leucocitos 11.7, Hb 8.5, Hcto 26. Test de Influenza A +.
Llega hipotensa e hiperglicémica, pero sin criterio de CAD ni SHH.
Es valorada por upc que descarta ingreso a unidad y sugieren escalar atb, realizar cultivo de secreción bronquial, broncodilatación y observación.
Durante estancia en servicio de medicina:
-Hemodinamico: Paciente con presiones estables, actualmente hemodinamia autosostenida, eucardica, dado mal acceso venoso se realiza instalacion de CVC, continuar cuidados de CVC

hoy en su dia 4. se mantiene terapia antihipertensiva de buen control actual. Hb: 9.7 con VCM y CHCM normales.
-Respiratorio: Paciente ingresada en contexto de IRA tipo II secundaria a NAC viral por Influenza A +, actualmente mejoria clinica, disminuye clinica y ruidos respiratorios, actualmente clinica estable, sin UMA, con más de 48h desde que se logra retiro de aporte suplementario de O2 para lograr Sat 97%, se continúa Terapia de broncodilatacion + KTR 2 veces al dia
-Infeccioso: Paciente con diagnostico de Nac viral por influenza A, con HC + para S. Epidermidis sensible a vancomicina, UC: positivo para E.Coli y K. pneumoniae BLEE +, CSB + para Enterobacter asburiae + | Stenotrophomonas maltophilia | candida Albicans, sensible a levofloxacio, parametros clinicos actuales estables, sin peak febriles, PCR en descenso, actualmente en 19,1, leucocitos dentro de rango normal, sin desviacion. paciente debe continuar con vancomicina EV en dosis actual hasta completar 7 dias, actualmente dia 6/7.
-Nefrourologico: Paciente con vejiga neurogenica de larga data, usuaria de CUP, con ITU recurriente, actualmente UC +, recibiendo ATB.
-Gastrointestinal: Paciente con constipacion, actualmente, con RHA aumentados, depocisiones diarreicas en 2 oportunidades el dia de ayer, se inicia metoclopramida + Hidratacion oral.
Plan de paciente involucra resolución de cuadro actual, terminar ATB acorde a relatado, apoyar con KNTR, resolución de destino final acorde a contexto social.

## INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo relativo asistido + Aislamiento de contacto (BLEE +)
2. 2. Regimen hipoglicemico, hiposodico
3. 3. Hidratacion oral abundante
4. 4. O2 suplementario para Sat >92%
5. 5. KTR + KTM 2 veces al dia
6. 6. CSV c/8 horas
7. 7. HGT control precomidas + Novorapid segun esquema
8. 8. Vancomicina 1gr c/12 horas ev (6/7)
9. 9. Tresiba 30 UI sc/dia
10. 10. Cuidados de enfermeria | PUPP | curacion diaria de lesiones
11. Omeprazol 20mg vo día
12. Metamizol 1 amp ev c8h SOS
13. Enoxaparina 60mg sc día
14. INSULINA ULTRA RAPIDA CATRIDGE 3 MINILITROS PRE COMIDAS 101-130: 9 UD 131-160: 10 UD 161-190: 11 UD 191-220: 12 UD 221-250: 13 UD 251-280 14UD 281-310 15UD 311-340 16UD
15. bisoprolol 2.5mg vo día
16. Ondansetron 1 amp ev c8h SOS
17. Metoclopramida 1 amp ev c8h SOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO